UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH UP UNIVERSITÉ **RECONNUE PAR L'ÉTAT** جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année universitaire : 2022-2023** **Niveau : 4ème année** **Examens Session Normale (Juin 2023)**	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH

1. Parmi les tumeurs épithéliales malignes primitives de l'ovaire, quel est la tumeur la plus fréquente ?

A. Mucineuses **B-** Séreuses **C** - A cellules transitionnelles
D. A cellules claires **E** - Endométrioïdes

2. Le Cystadénocarcinome séreux de haut grade de l'ovaire

A. Est souvent étendu et d'évolution rapide
B. Est caractérisé par une mutation des gènes P53, BRCA
C. Peut naitre de novo ou à partir de lésion de STICs (Séreuse tubaire intraépithéliale carcinome)
D. Est souvent une évolution d'une tumeur borderline de l'ovaire
E. Est caractérisé par une mutation des gènes Mutation BRAF, KRAS, PTNE

3. Vous recevez au laboratoire une pièce de kystectomie ovarienne d'une jeune femme de 20ans. A l'ouverture, elle comporte un contenu pilo-sébacé avec une dent. L'étude histologique retrouve de nombreux tissus exclusivement matures. Quel est votre diagnostic?

A. Un tératome mature pluri-tissulaire
B. Un cystadénome séreux
C. Un cystadénome mucineux
D. Un tératome immature pluri-tissulaire
E. Un dysgerminome

4. Le pronostic du lymphome hodgkinien classique :

A- Dépend du stade
B- Dépend du sous type histologique
C- Est meilleur pour le lymphome hodgkinien classique de sous type déplétion lymphocytaire
D- Dépend de la classification Ann Arbor
E- Dépond de l'état général du patient

5. Lymphome hodgkinien nodulaire à prédominance lymphocytaire de Poppema-lennert

A- Est le plus fréquent des lymphomes hodgkiniens
B- Serait plus un lymphome B d'origine folliculaire
C- Se caractérise par les cellules lacunaires
D- Se caractérise par les cellules dites en « pop corn »
E- Est toujours associée à l'EBV

6. Le lymphome d'hodgkin

A- Est une maladie curable
B- Le début est souvent stéréotypé
C- Nécessite un bilan d'extension complet
D- Le stade d'Ann Arbor détermine le pronostic et les indications thérapeutiques
E- Comporte des cellules tumorales exprimant l'anticorps anti CD15 et anti CD30

7. Les quatre sous-types du lymphome hodgkinien classique sont :

A- Sous-type scléronodulaire
B- Sous-type à cellularité mixte
C- Sous type nodulaire à prédominance lymphocytaire
D- Sous-type riche en lymphocytes
E- Sous-type en déplétion lymphocytaire

8. Les critères de risque de malignité devant un adénome colorectal englobent :

A- La composante villeuse prédominante
B- Le sexe masculin
C- Le siège rectal
D- La durée d'évolution longue
E- La taille > 1cm

9. Une lésion polypoide colorectale :

A. Est une lésion macroscopique qui fait saillie dans la lumière colorectale
B. Peut être de nature inflammatoire
C. Est toujours de nature adénomateuse
D. Doit être vérifiée histologiquement
E. Peut correspondre à de nombreuses entités anatomo-cliniques différentes

10. Entourer les facteurs incriminés dans la genèse d'un adénome colorectal

A. La consommation excessive de viande rouge
B. La consommation excessive de légumes et de fruits
C. L'intoxication alcoolo-tabagique
D. La carence en folates
E. La prise régulière d'aspirine

11. L'adénome tubuleux :

A. Est le type le plus fréquent 80%
B. Est fait de 75% des structures glandulaires
C. Comporte des Digitations munis d'un axe conjonctif
D. Peut-être en dysplasie de haut grade
E. Risque d'évoluer vers un adénocarcinome

12. La polypose adénomateuse familiale :

A. Est une atteinte majeure ou mineure selon le nombre de polypes
B. Se caractérise par la mutation du gène APC
C. Peut comporter des lésions de dysplasie de haut grade
D. Nécessite une enquête génétique familiale
E. Le risque de cancer est minime

13. Cochez les nouveaux facteurs pronostiques d'un adénocarcinome colorectal

A. Les emboles veineux **B.** L'emboles lymphatique **C.** La taille tumorale
D. Le budding **E.** L'envahissement ganglionnaire

14. Le compte rendu anatomopathologique en matière de cancer rectal doit préciser:

A. La limite circonférentielle
B. Le degré de différentiation des adénocarcinomes
C. La présence ou non d'emboles vasculaires
D. Le type histologique
E. L'état des limites d'exérèse chirurgicales

15. À propos des tumeurs hépatiques

A. Elles sont définies uniquement comme l'ensemble des proliférations tumorales se développant au dépend des constituants du tissu hépatique
B. Elles peuvent être secondaires
C. Sont souvent associées à une cirrhose hépatique si elles sont primitives
D. Peuvent être au dépend des éléments vasculaires du foie
E. Peuvent être au dépend des voies biliaires intra-hépatiques

16. Concernant l'origine tissulaire des tumeurs primitives hépatiques

A. Le carcinome hépatocellulaire provient des structures hépatocytaires
B. Le cholangiocarcinome provient des structures biliaires
C. Les structures vasculaires ne donnent pas de tumeurs primitives hépatiques
D. Il peut exister des tumeurs mixtes
E. Il peut exister des tumeurs d'origine embryonnaire

17. L'hépatoblastome :

- **A.** Est une tumeur embryonnaire qui atteint surtout l'enfant
- **B.** Se caractérise biologiquement par une augmentation sérique de l'AFP
- **C.** Se révèle par une hépatomégalie tumorale
- **D.** La biopsie hépatique est contre indiquée
- **E.** Son traitement est basé sur la chirurgie première suivi de la chimiothérapie

18. La localisation secondaire au niveau hépatique d'une tumeur maligne

- **A-** Est plus fréquente qu'une tumeur primitive
- **B-** Est le plus souvent due à un néoplasme d'origine digestive
- **C-** Est le plus souvent multinodulaire
- **D-** Est rare
- **E-** Peut-être révélatrice d'un cancer

19. Les lésions bénignes élémentaires du sein comprennent :

- **A-** La mastite granulomateuse
- **B-** La mastose sclérokystique (MSK)
- **C-** Les papillomes intracanalaires
- **D-** Les adénofibromes
- **E-** Le carcinome mammaire infiltrant de type non spécifique

20. L'adénofibrome mammaire :

- **A-** Est la tumeur bénigne la plus fréquente
- **B-** Survient à tout âge
- **C-** Se présente comme une opacité nodulaire bien limitée à la mammographie
- **D-** Est une tumeur fibro-épithéliale
- **E-** Se présente comme une opacité mal limitée classée ACR5 à la mammographie

21. Le carcinome épidermoïde du poumon :

- **A-** Est souvent périphérique
- **B-** Constitue un bourgeon endobronchique
- **C-** Peut-être nécrosé et excavé
- **D-** Peut-être bien, moyennement ou peu différencié
- **E-** Comporte des cellules tumorales expriment l'anticorps anti P40 en immunohistochimie

22. L'aspect microscopique du carcinome à petites cellules du poumon montre :

- **A-** Des cellules de petite taille, fragiles et écrasées
- **B-** Des structures glandulaires
- **C-** Un index mitotique élevé
- **D-** Des globes cornés
- **E-** Nécrose tumorale

23. L'évaluation du grade de Scarff Bloom Richardson (SBR) est fondée sur 3critères :

- **A-** La différentiation glandulaire
- **B-** Les embols vasculaires
- **C-** Le nombre de mitoses
- **D-** Les atypies cyto-nucléaires
- **E-** La stroma réaction

24. Quel fixateur utilise-t-on pour un prélèvement d'une lésion mammaire infraclinique? (1 réponse est juste)

- **A-** Glutaraldéhyde
- **B-** Cytospray
- **C-** Formol
- **D-** Mélange alcool ether
- **E-** Bouin

25. Entourer les cancers du sein HER2 positifs et éligible à un traitement par la trastuzumab

- **A-** Her 2 (0)
- **B-** Her 2 (1+)
- **C-** Her 2 (2+) non amplifié en hybridation in situ
- **D-** Her 2 (3+)
- **E-** Her 2 (2+) amplifié en hybridation in situ

26. Devant une suspicion de tumeur testiculaire, le diagnostic se fait sur :

A- Une cytoponction
B- Une biopsie
C- Des copeaux de résection endoscopique
D- Une orchidectomie
E- Une exérèse partielle

27. Vous recevez au laboratoire un prélèvement pour tumeur testiculaire. A la coupe, la tumeur est bien limitée, homogène de couleur beige-rosé. A ce stade, quel est le diagnostic le plus probable ?

A- Le carcinome embryonnaire
B- Le tératome
C- Le choriocarcinome
D- Le séminome
E- Le yolk sac tumor

28. Dans ce cas, vous trouverez à l'examen histologique :

A- Des cellules tumorales associées à des lymphocytes et des granulomes
B- Des tubes, cordons et massifs formés de cellules monomorphes atypiques
C- Des corps de Shiller Duval
D- Des boyaux de cellules jointives avec dyskératose
E- Un infiltrat de cellules en bague à chatons

29. Vous décidez de faire une étude immunohistochimique pour vous aider dans votre diagnostic. Quel est l'anticorps qui sera positif ?

A- bHCG
B- αFP
C- PLAP
D- CD30
E- Tdt

30. Lors de la prise en charge approfondie macroscopique de la tumeur, vous notez la présence d'un foyer hémorragique. Cet aspect vous fait suspecter une tumeur testiculaire mixte. Quels sont les 2 tumeurs que vous suspectez en premier :

A- La tumeur du sinus endodermique
B- Le carcinome embryonnaire
C- Le teratome malin mature
D- Le choriocarcinome
E- La tumeur des cellules de Sertoli

31. Dans ce cas, quels sont les 2 anticorps immunohistochimiques qui vont vous aider (un anticorps sera positif par chaque tumeur) ?

A- bHCG
B- αFP
C- PLAP
D- CD30
E- Tdt

32. L'examen histologique d'une biopsie prostatique d'un patient de 60 ans retrouve un adénocarcinome prostatique d'architecture uniforme avec 2 grades de différenciation : 4 à 20%, 5 à 10% et 3 à 70 %. Le score de gleason est de?

A. 6 **B.** 7 **C.** 8
D. 9 **E.** 10

33. Vous écrivez le compte rendu de la manière suivante :

A. Score de Gleason (3 + 4) **B.** Score de Gleason (4 + 3) **C.** Score de Gleason (3 + 5)
D. Score de Gleason (5 + 3) **E.** Score de Gleason (4 + 5)

34. A quel groupe grade appartient ce patient ?

A. Groupe grade 1
B. Groupe grade 2
C. Groupe grade 3
D. Groupe grade 4
E. Groupe grade 5

35. En pathologie prostatique, pour différencier un Pin de haut grade d'un adénocarcinome infiltrant, quels sont les 2 anticorps que l'on utilise :

A. L'HER2
B. La Racémase
C. Le ki67
D. Le CD30
E. La P63

36. Quel anticorps sera exprimé par les 2 diagnostics ?

A. L'HER2
B. La Racémase
C. Le ki67
D. Le CD30
E. La P63

37. Dans la rédaction d'un compte rendu pour biopsie prostatique concernant les lésions PIN, seul le PIN de haut grade doit-être rapporté :

A. Vrai
B. Faux

38. Vous recevez un appel d'un chirurgien travaillant à distance de tout laboratoire, il souhaite vous envoyer un ganglion pour examen anatomopathologique. Le patient présente plusieurs adénopathies au niveau cervical et inguinal. Vous lui conseillez de : (plusieurs réponses possibles)

A. Privilégier le site inguinal
B. Privilégier le site cervical
C. De faire une biopsie partielle
D. De faire une biopsie exérèse
E. De fournir des renseignements cliniques complets

39. Le ganglion sera choisi sur son aspect macroscopique. Le chirurgien choisira le ganglion :

A. Rond
B. Mobile
C. Dur
D. Réniforme
E. Fixe

40. Concernant le conditionnement du ganglion, Le chirurgien devra pour le ganglion prélevé (laboratoire à distance):

A. L'envoyer à l'état frais
B. Le couper en deux
C. Faire des appositions
D. Le mettre dans une compresse imbibée de sérum physiologique
E. Le fixer

41. Arrivé au laboratoire, vous examinez le ganglion. Vous notez un aspect chair de poisson. A ce stade, quel est le diagnostic le plus probable ?

A. Un sarcome
B. Un carcinome
C. Un mélanome
D. Un séminome
E. Un lymphome

42. Dans ce cas, vous trouverez à l'examen histologique :

A. Une prolifération tumorale fusocellulaire
B. Des boyaux de cellules jointives avec des globes cornées
C. Un infiltrat de cellules lymphomateuses
D. Une prolifération riche en cellules en bague à chatons
E. Une prolifération à cellules claires

43. L'examen plus approfondi met en évidence des cellules tumorales de taille moyenne avec un aspect de ciel étoilé. Cet aspect évoque :

A. Un adénocarcinome
B. Un carcinome épidermoïde

C. Un lymphome de Burkitt
D. Un myélome
E. Un lymphome lymphoblastique

44. Vous décidez de faire une étude immunohistochimique pour vous aider dans votre diagnostic. Quel est le premier panel d'anticorps que vous allez utiliser ?
A. Cytokératine20
B. CD20
C. Cytokératine7
D. CD3
E. Ki67

45. En deuxième intention, un autre anticorps est d'une aide précieuse Lequel ?
A. Cytokératine20
B. CD20
C. Cytokératine7
D. CD3
E. Ki67

46. Ce dernier sera positif à hauteur de :
A. 20 %
B. 40 %
C. 60 %
D. 80 %
E. 100 %

47. Devant une suspicion de métastase ganglionnaire, le premier site d'invasion ganglionnaire est à rechercher au niveau?
A. De la zone folliculaire
B. De la zone parafolliculaire
C. De la médullaire
D. De la pulpe rouge
E. En sous-capsulaire

48. Devant une tumeur papillaire de la vessie composée de papilles épaisses et fusionnées avec une désorganisation architecturale majeure et atypies marquées, vous concluez à ?
A. Un papillome
B. Une néoplasie papillaire de faible potentiel de malignité
C. Un carcinome papillaire de bas grade
D. Un carcinome papillaire de haut grade
E. Un carcinome In Situ

49. Dans ce cas, cocher les réponses correctes concernant le facteur histo-pronostic majeur ayant des répercussions chirurgicales sur le plan de la prise en charge thérapeutique ?
A. Une infiltration de la muqueuse
B. Une infiltration de la sous-muqueuse
C. Une infiltration de la musculeuse
D. Une infiltration du Detrusor
E. Un stade pT2

50. Parmi les tumeurs suivantes, l'helicobacter pylori est incriminé dans la genèse de 2 cancers lesquels ?
A. La tumeur stromale gastro-intestinales GIST
B. Le sarcome de kaposi
C. Le lymphome de MALT
D. Le carcinome épidermoïde
E. L'adénocarcinome

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech

Année Universitaire : 2022-2023

MED4E03 Anatomie pathologie II et III 2022-2023

Anatomie pathologie II et III
RAIS Hanane

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☐	☐
Q2	☒	☒	☒	☐	☐
Q3	☒	☐	☐	☐	☐
Q4	☒	☒	☐	☒	☒
Q5	☐	☒	☐	☒	☐
Q6	☒	☒	☒	☒	☒
Q7	☒	☒	☐	☒	☒
Q8	☒	☒	☒	☒	☒
Q9	☒	☒	☐	☒	☒
Q10	☒	☐	☒	☒	☐
Q11	☒	☒	☐	☒	☒
Q12	☒	☒	☒	☒	☐
Q13	☒	☐	☐	☒	☐
Q14	☒	☒	☒	☒	☒
Q15	☐	☒	☒	☒	☒
Q16	☒	☒	☐	☒	☒
Q17	☒	☒	☒	☐	☒
Q18	☒	☒	☒	☐	☒
Q19	☒	☒	☒	☒	☐
Q20	☒	☒	☒	☒	☐
Q21	☐	☒	☒	☒	☒
Q22	☒	☐	☒	☐	☒
Q23	☒	☐	☒	☒	☐
Q24	☐	☐	☒	☐	☐
Q25	☐	☐	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☐	☐	☒	☐
Q27	☐	☐	☐	☒	☐
Q28	☒	☐	☐	☐	☐
Q29	☐	☐	☒	☐	☐
Q30	☐	☒	☐	☒	☐
Q31	☒	☐	☐	☒	☐
Q32	☐	☐	☒	☐	☐
Q33	☐	☐	☒	☐	☐
Q34	☐	☐	☐	☒	☐
Q35	☐	☒	☐	☐	☒
Q36	☐	☒	☐	☐	☐
Q37	☒	☐	☐	☐	☐
Q38	☐	☒	☐	☒	☒
Q39	☒	☐	☒	☐	☒
Q40	☐	☒	☒	☐	☒
Q41	☐	☐	☐	☐	☒
Q42	☐	☐	☒	☐	☐
Q43	☐	☐	☒	☐	☐
Q44	☐	☒	☐	☒	☐
Q45	☐	☐	☐	☐	☒
Q46	☐	☐	☐	☐	☒
Q47	☐	☐	☐	☐	☒
Q48	☐	☐	☐	☒	☐
Q49	☐	☐	☒	☒	☒
Q50	☐	☐	☒	☐	☒

Pr RAIS